Boletín Epidemiológico N° 26 de 2025

Dirección de Vigilancia de la Salud

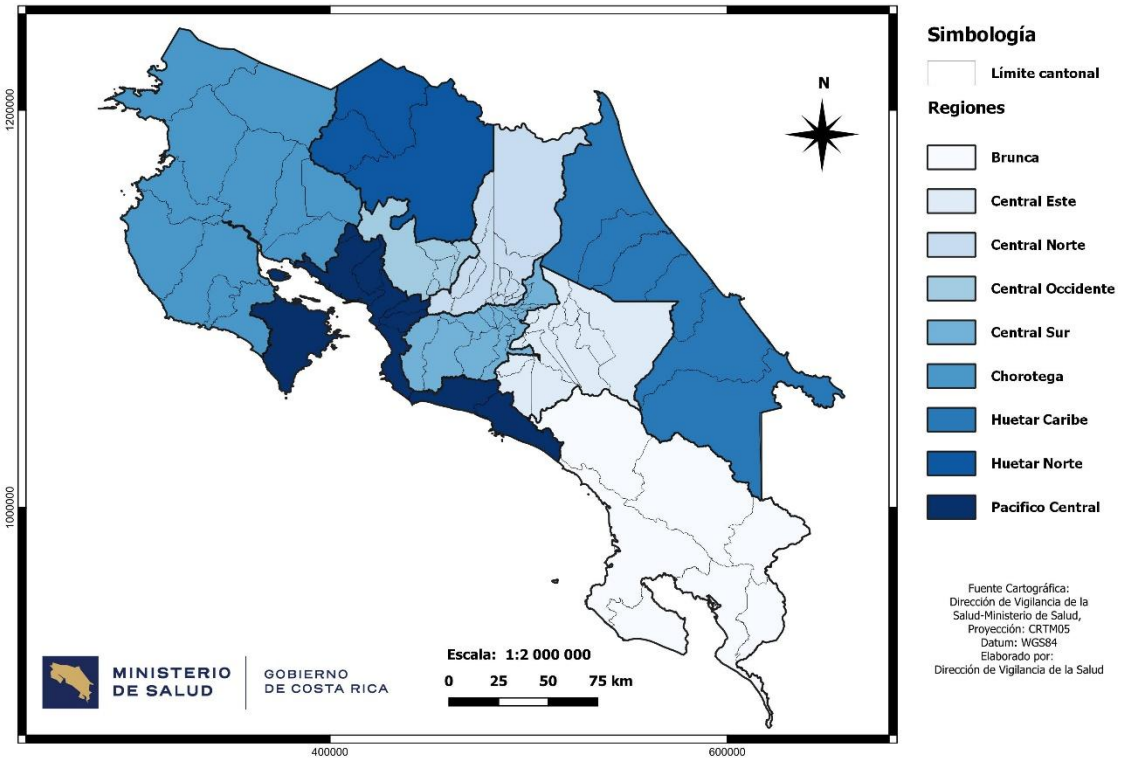
Ministerio de Salud

18 de julio de 2025

Tabla de contenido

Arbovirosis 3
Acciones de control vectorial realizadas en el país a la semana epidemiológica 27 .. 9
Malaria 11
Situación epidemiológica de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA). 19
Infecciones de transmisión sexual 22
Miasis por gusano barrenador en humanos 34
Reporte del primer semestre de Recolección de llantas en desuso 42

Costa Rica. Regionalización Ministerio de Salud, 2024



Arbovirosis

Adriana Alfaro Nájera
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de Salud

Adrián Montero Bonilla
Unidad de Seguimiento de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

Dengue

A la semana epidemiológica 27 del año 2025 se notifican **2414 casos** de dengue, de estos 28 acumulados notificados con signos de alarma.

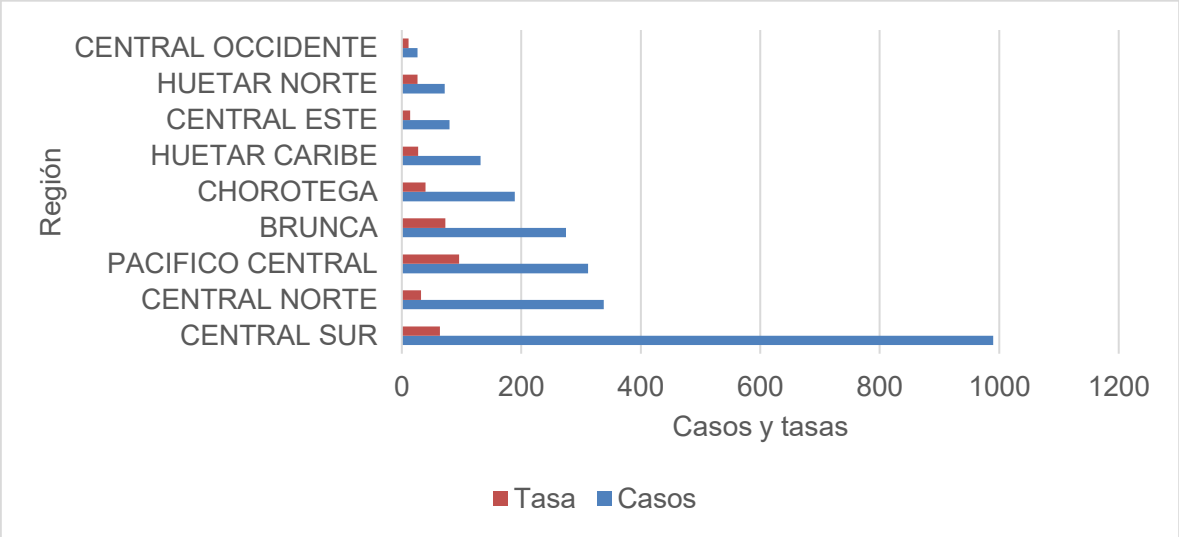
En la región Central Sur se concentra la mayor notificación acumulada con 990 casos y la tasa más alta en la Pacífico Central 96,1/100.000 habitantes.

Tabla 1.
Costa Rica: Casos y tasas de dengue por región a la semana epidemiológica 27, 2025 (Tasa por 100.000 hab.)

Región	Casos	Tasa
Central Sur	990	63,8
Central Norte	338	32,0
Pacifico Central	312	96,1
Brunca	275	72,6
Chorotega	189	39,6
Huetar Caribe	132	27,3
Central Este	80	13,8
Huetar Norte	72	26,4
Central Occidente	26	11,3
Total	2414	45,1

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Figura 1.
Costa Rica: casos de dengue y tasa por región a la semana epidemiológica 27, 2025.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

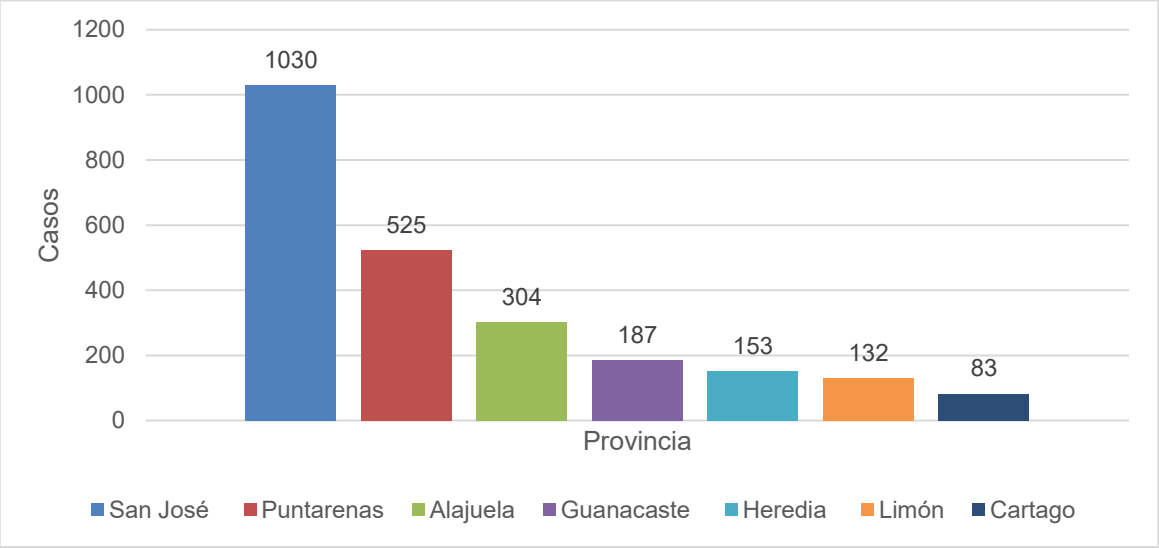
En la tabla 2 se pueden observar los casos notificados por provincia y sexo para el año 2025.

Tabla 2.
Costa Rica: casos de dengue notificados por provincia y sexo, 2025

Provincia	Total casos	Tasa	Femenino	Tasa	Masculino	Tasa
San José	1030	60,0	524	60,7	506	59,3
Puntarenas	525	99,5	232	89,4	293	109,3
Alajuela	304	27,8	161	29,8	143	25,9
Guanacaste	187	44,5	82	39,6	105	49,3
Heredia	153	27,4	71	25,5	82	29,3
Limón	132	27,3	50	21,3	82	33,0
Cartago	83	14,9	33	11,9	50	17,9
Total	**2414**	**45,1**	**1153**	**43,3**	**1261**	**46,8**

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Figura 2.
Costa Rica: casos de dengue notificados por provincia a la semana epidemiológica 27, 2025.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

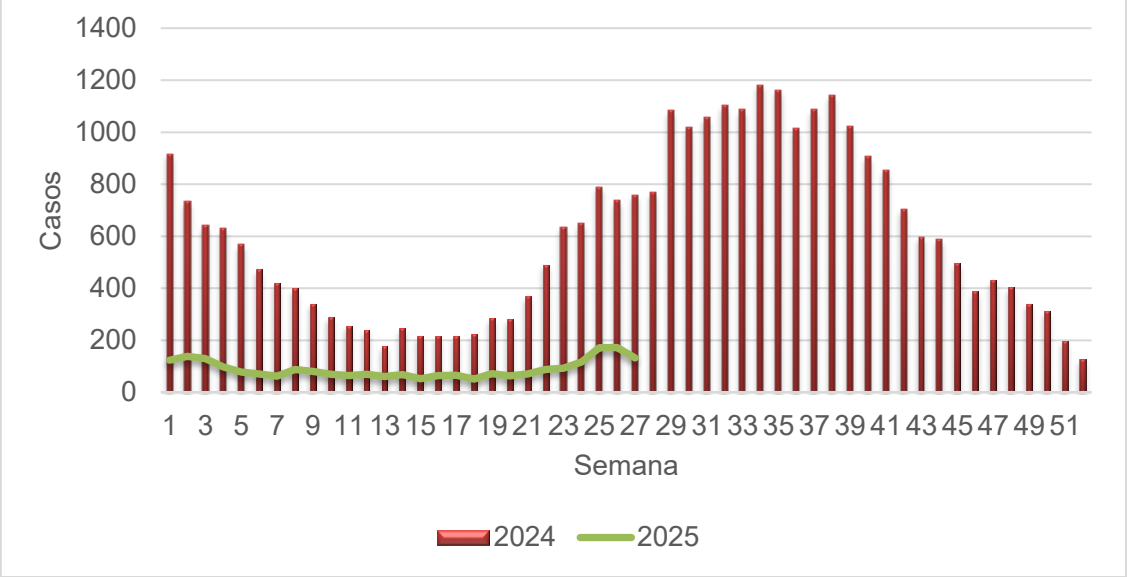
Los cantones con mayor número de casos acumulados a la semana epidemiológica 27 son: San José 643 casos, Alajuela 140 casos, Esparza 115 casos, Puntarenas 103 casos, y Sarapiquí 98 casos.

Tabla 3.
Costa Rica: cantones prioritarios en casos de dengue a la semana epidemiológica 27, 2025.

Cantón	Casos	Tasa
101: San José	643	179,6
201: Alajuela	140	42,1
602: Esparza	115	282,1
601: Puntarenas	103	69,0
410: Sarapiquí	98	103,6
110: Alajuelita	87	86,3
605: Osa	78	246,2
610: Corredores	72	130,9
103: Desamparados	64	25,1
607: Golfito	61	127,4
210: San Carlos	52	24,2
702: Pococí	48	29,9
109: Santa Ana	43	67,4
119: Pérez Zeledón	43	30,0
502: Nicoya	37	62,6
609: Parrita	32	144,7
510: La Cruz	28	94,9
506: Cañas	26	75,6
118: Curridabat	25	30,4
113: Tibás	24	27,4

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

Figura 3.
Costa Rica: casos de dengue a la semana epidemiológica 27, 2024-2025.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

A la semana epidemiológica 27 del 2024 se reportó un total de 12196 casos de dengue, para este 2025 se reportan 2414 para un descenso del 80%.

Tabla 4.
Costa Rica: casos de dengue a la semana epidemiológica 27, 2024-2025.

Semana	2024	2025
1	917	124
2	735	138
3	641	130
4	631	98
5	568	78
6	472	71
7	421	62
8	401	88
9	340	81
10	289	69
11	256	65
12	238	69
13	178	61
14	247	68

15	216	52
16	214	65
17	216	66
18	223	51
19	285	72
20	280	63
21	368	71
22	489	88
23	636	93
24	648	116
25	790	171
26	739	172
27	758	132
Total	**12196**	**2414**

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

Acciones de control vectorial realizadas en el país a la semana epidemiológica 27

Rodrigo Marín Rodríguez
Programa de Control de Vectores
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud.

Rose Mary Hidalgo Ríos
Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria (IREM)

En la siguiente tabla se desglosan las acciones de control vectorial que se han realizado en la Semana Epidemiológica 27 del 2025, por el personal de Control de Vectores del país.

Cuadro 1.
Costa Rica: Acciones de control vectorial en la Semana Epidemiológica 27

	Total
Viviendas visitadas	**10.971**
Viviendas positivas	**785**
Depósitos tratados	**49.443**
Depósitos eliminados	**18.746**
Depósitos positivos	**1.001**
Viviendas fumigadas	**7.516**

Fuente: Consolidado Nacional de actividades de Control Vectorial.

Así mismo se detalla lo que llevamos de la Semana Epidemiológica 1 a la 27.

	Total
Viviendas visitadas	**334.572**
Viviendas positivas	**14.909**
Depósitos tratados	**1.245.667**
Depósitos eliminados	**889.550**
Depósitos positivos	**26.086**
Viviendas fumigadas	**321.645**

Fuente: Consolidado Nacional de actividades de Control Vectorial.

Malaria

Isaac Vargas Roldán
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Sarah Arce Bonilla
Dirección de Vigilancia de la Salud

I. Antecedentes

Costa Rica ha logrado mantener bajos niveles de transmisión de malaria gracias a los esfuerzos continuos y control. Los casos han disminuido notablemente en comparación con el pasado.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud (MINSA) lideran los esfuerzos de vigilancia, diagnóstico y tratamiento de la malaria, junto con el apoyo del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa). Se utilizan herramientas para el diagnóstico rápido y monitoreo constante de los casos.

Costa Rica forma parte de la **Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria en Mesoamérica y República Dominicana (IREM)** es un esfuerzo conjunto de varios países y organizaciones internacionales con el objetivo de eliminar la malaria en esta región. Esta iniciativa busca coordinar acciones, compartir recursos y conocimientos, y establecer estrategias comunes para combatir y erradicar esta enfermedad.

El objetivo principal para este año es mantener la reducción sostenida de casos de malaria y avanzar hacia la meta de eliminación. Costa Rica se perfila como el próximo país de la región en obtener la certificación de cero casos autóctonos de malaria.

Como parte de las acciones se está priorizando el **fortalecimiento de la red de colaboradores voluntarios** en comunidades con barreras de acceso a los servicios de salud y esfuerzos para acerca el diagnóstico y tratamiento a personas en condición de movilidad humana que llevan su paso por el país.

II. Vigilancia epidemiológica

El histórico de transmisión local de malaria presenta los casos registrados en los años 2023, 2024 y 2025, organizados por semana epidemiológica. Se observa una tendencia general a la disminución de casos en el periodo analizado.

Durante el periodo comprendido entre las semanas epidemiológicas 1 a 27, se observa una disminución progresiva en el número de casos de transmisión local de malaria a lo largo de los últimos tres años. En el año 2023, se registraron 359 casos, mientras que en 2024 la cifra se redujo a 156 casos, lo que representa una disminución del 56%. En lo que va del año 2025, se han reportado 6 casos, lo que equivale a una reducción del 98% en comparación con el mismo periodo de 2023.

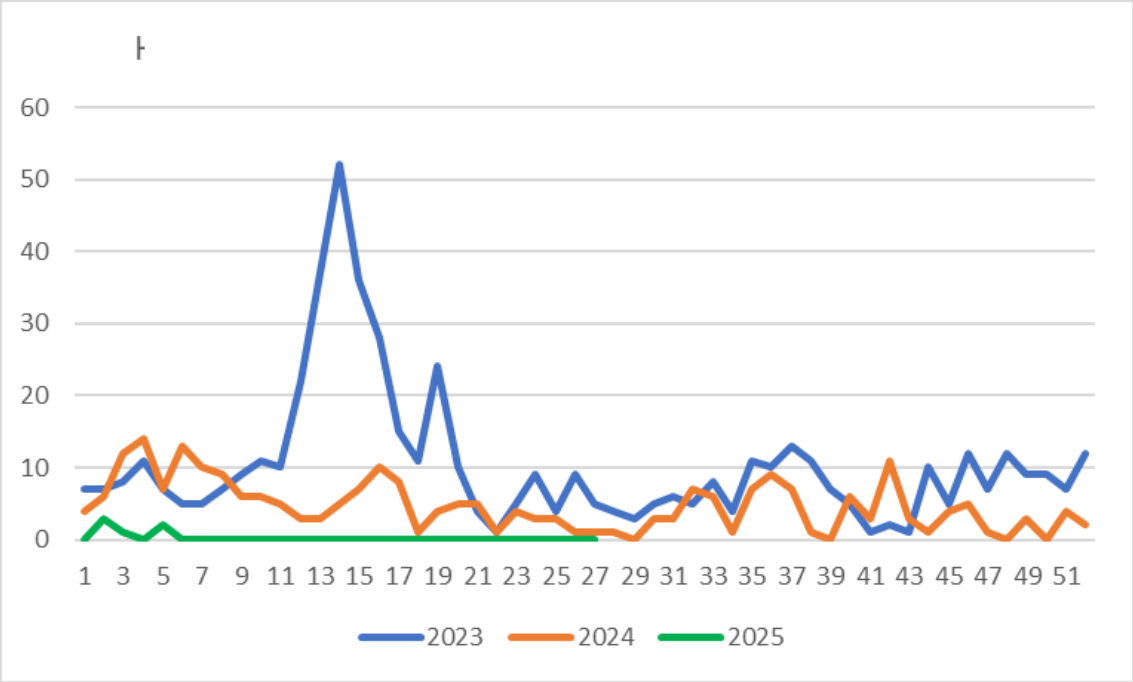
Adicionalmente, en lo que va del año 2025, se ha registrado 1 caso introducido en Santa Rosa de Pocosol y se han detectado 14 casos importados de malaria, de los cuales el 79 % corresponden a *Plasmodium vivax* (n=11) y el 21 % a *P. falciparum* (n=3), con transmisión ocurrida fuera del país.
Estos casos fueron identificados en las localidades de San Pablo (Nandayure), San Ramón (San Ramón), Corredores, Pavas (San José), Cutris (San Carlos) y Los Chiles.
Las personas afectadas se desempeñan principalmente como operarios de construcción, peones agrícolas y coligalleros, así como personas en condición de movilidad humana, provenientes de Nicaragua, de la ruta migratoria desde América del Sur, o en retorno desde México y Gabón (África).
Adicionalmente, se tienen 5 casos del foco de Crucitas en estudio, lo que suma un total de 31 casos reportados en lo que va del año.

Tabla 1.
Costa Rica: Comportamiento de casos de transmisión local del año 2023, 2024 y 2025 a SE26.

Histórico Transmisión local			
Semana Epidemiológica	2023	2024	2025
1	7	4	0
2	7	6	3
3	8	12	1
4	11	14	0
5	7	7	2
6	5	13	0
7	5	10	0
8	7	9	0
9	9	6	0
10	11	6	0
11	10	5	0
12	22	3	0
13	37	3	0
14	52	5	0
15	36	5	0
16	28	7	0
17	15	8	0
18	11	1	0
19	24	4	0
20	10	5	0
21	4	5	0
22	1	1	0
23	5	4	0
24	9	3	0
25	4	3	0
26	9	1	0
27	5	1	0
Total	**359**	**156**	**6**

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Gráfico 1.
Costa Rica: Comportamiento de casos de transmisión local del año 2023, 2024 y 2025 a SE 27.



Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Producción de pruebas de diagnóstico

Se ha llevado a cabo un exhaustivo monitoreo a nivel nacional de la malaria, por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud realizando pruebas de diagnóstico mediante búsquedas pasivas y activas de casos.

A semana epidemiológica 27, se registraron 71.152 pruebas de diagnóstico, las cuales responden a las búsquedas realizadas por las instituciones, desglosadas de la siguiente manera, (refiérase a la figura 1):

- **Pruebas de diagnóstico rápido realizadas por el Ministerio de Salud**: 33.193 referirse a la tabla 2.
    - **Colaboradores Voluntarios**: 766
    - **Inspectores de Salud**: 32.427

- **Pruebas de diagnóstico realizadas por CCSS**: 37.959, referirse al gráfico 3.
    - **Gotas gruesas**: 6.815
    - **Pruebas de diagnóstico rápido**: 30.787
    - **PCR**: 357

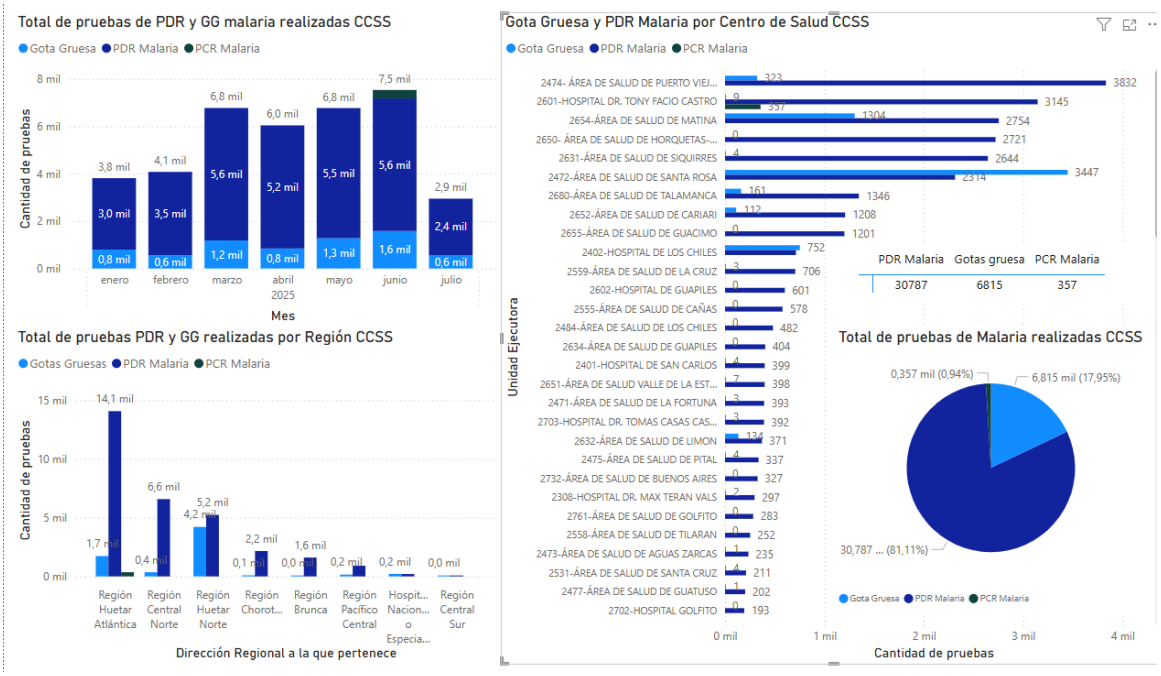
Estas cifras reflejan un esfuerzo coordinado y continuo para identificar y controlar la propagación de la malaria en el país. La combinación del método tradicional como lo es la gota gruesa y las pruebas rápidas permite una detección más amplia y oportuna de casos, contribuyendo significativamente a la vigilancia epidemiológica y al manejo efectivo de esta enfermedad.
Nota: El registro puede incluir datos duplicados, ya que se toman en cuenta las Gotas Gruesas (GG) para cuantificar la parasitemia antes de iniciar el tratamiento, ante una Prueba de Diagnóstico Rápido (PDR) positiva.

Tabla 2.
Costa Rica: Vigilancia generada por inspectores de salud y voluntarios

Región	Pruebas realizadas por Inspectores de Salud	Pruebas realizadas por voluntarios
Brunca	11484	54
Central Norte	168	28
Chorotega	4628	137
Huetar Caribe	6842	210
Huetar Norte	8014	305
Pacífico Central	1290	32
Total	32427	766

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Gráfico 3.
Costa Rica: Producción de gotas gruesas y PDRs por parte de CCSS



Fuente: CCSS.

Tabla 2.
Costa Rica: Producción de gotas gruesas y PDRs por parte de CCSS por región

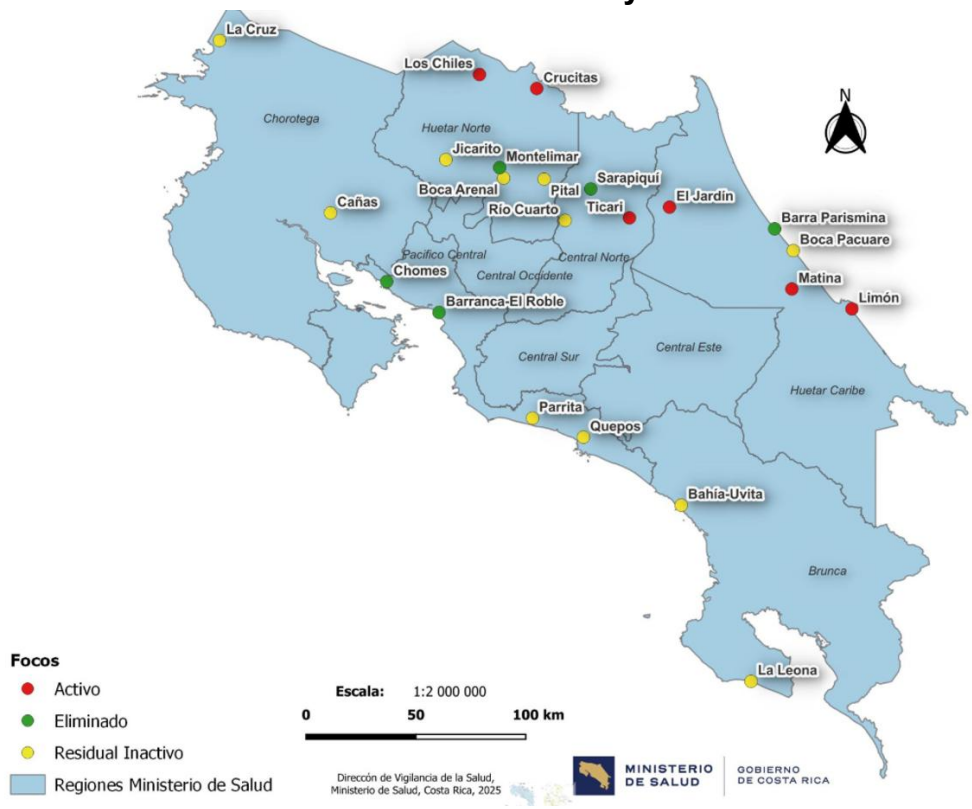
Dirección Regional a la que pertenece	Gotas Gruesas	PDR Malaria	PCR Malaria
Región Huetar Atlántica	1731	14072	357
Región Central Norte	354	6581	
Región Huetar Norte	4212	5237	
Región Chorotega	89	2161	
Región Brunca	33	1606	
Región Pacífico Central	150	905	
Hospitales Nacionales o Especializados	214	202	
Región Central Sur	32	23	
Total	**6815**	**30787**	**357**

Fuente: CCSS.

III. Inventario de focos.

En el país se cuenta con un inventario de focos en constante actualización, actualmente se tienen 6 focos activos, 10 focos residuales inactivos y 5 focos eliminados.

Figura 1.
Costa Rica: Inventario de focos de Malaria a mayo 2025.



Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

IV. Clasificación del estado histórico y actual de los focos maláricos.

Para que un foco sea declarado como residual inactivo debe transcurrir 1 año sin aparición de casos autóctonos, paralelamente, para que un foco sea declarado como eliminado, debe transcurrir 3 años sin transmisión autóctona del parásito.

Tabla 3.
Costa Rica: Listado de Focos de malaria a Enero 2025, por provincia, cantón y estado actual del foco.

Provincia	Cantón	Nombre del Foco	Estado
Alajuela	San Carlos	Pital	Residual inactivo
Alajuela	San Carlos	Boca Arenal	Residual inactivo
Alajuela	San Carlos	Monterrey	Eliminado
Alajuela	San Carlos	Crucitas - Llano Verde	Activo
Alajuela	Los Chiles	Los Chiles	Activo
Alajuela	San Carlos	Jicarito	Residual inactivo
Alajuela	Río Cuarto	Rìo Cuarto	Residual inactivo
Guanacaste	La Cruz	La Cruz	Residual inactivo
Guanacaste	Cañas	Cañas	Residual inactivo
Heredia	Sarapiquí	Sarapiquí	Eliminado
Heredia	Sarapiquí	Ticari	Activo
Limón	Matina	Matina	Activo
Limón	Limón	Limón	Activo
Limón	Siquirres	Barra de Parismina	Eliminado
Limón	Pococí	El Jardín	Activo
Limón	Siquirres	Barra Pacuare	Residual inactivo
Puntarenas	Roble	El Roble	Eliminado
Puntarenas	Puntarenas	Chomes	Eliminado
Puntarenas	Quepos	Quepos	Residual inactivo
Puntarenas	Parrita	Parrita	Residual inactivo
Puntarenas	Golfito	La Leona	Residual inactivo
Puntarenas	Osa	Bahia Uvita	Residual inactivo

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

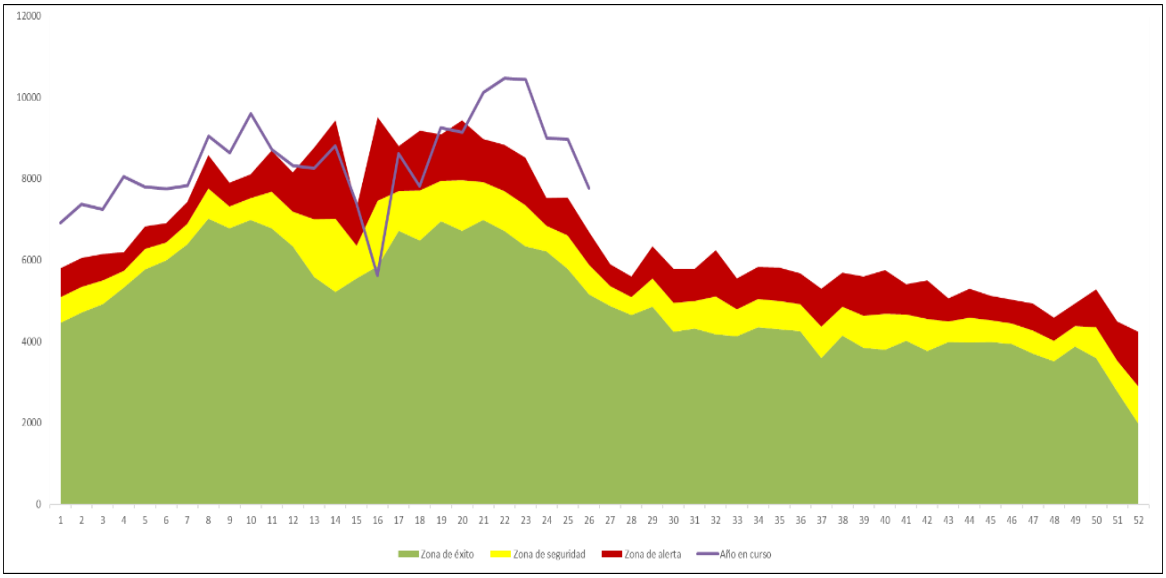
Situación epidemiológica de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) al 14 de julio 2025.

Ivannia Caravaca Rodríguez.
Unidad de Epidemiología.
Dirección de Vigilancia de la Salud

En la semana epidemiológica 27 del 2025 se presentan 219914 casos acumulados de EDA. Según el comportamiento epidemiológico de este evento, se denota una curva epidémica en zona de alerta, con una tasa de 4106 casos de diarrea por cada 100 000 habitantes.

La incidencia de las EDA para la Semana Epidemiológica (SE) 27 refleja una disminución de casos notificados en relación con el 2023, año referente por el registro del aumento de casos y tasas por 100 000 habitantes en todo el territorio nacional. Para la SE 27 se continúa observando una predisposición disminuida en la frecuencia de casos, observándose una tendencia a la baja comparado con los años anteriores, es evidente que los fenómenos climáticos del niño y la niña afectan la cantidad de casos de diarrea, este año con el fenómeno de la niña se muestra a la fecha el canal endémico en zona de alerta situación semejante en el año 2023 donde se atravesó el mismo fenómeno. Se destaca que los datos son preliminares, y actualmente se encuentran los datos en revisión, por lo que puede presentarse afectación en el canal endémico.

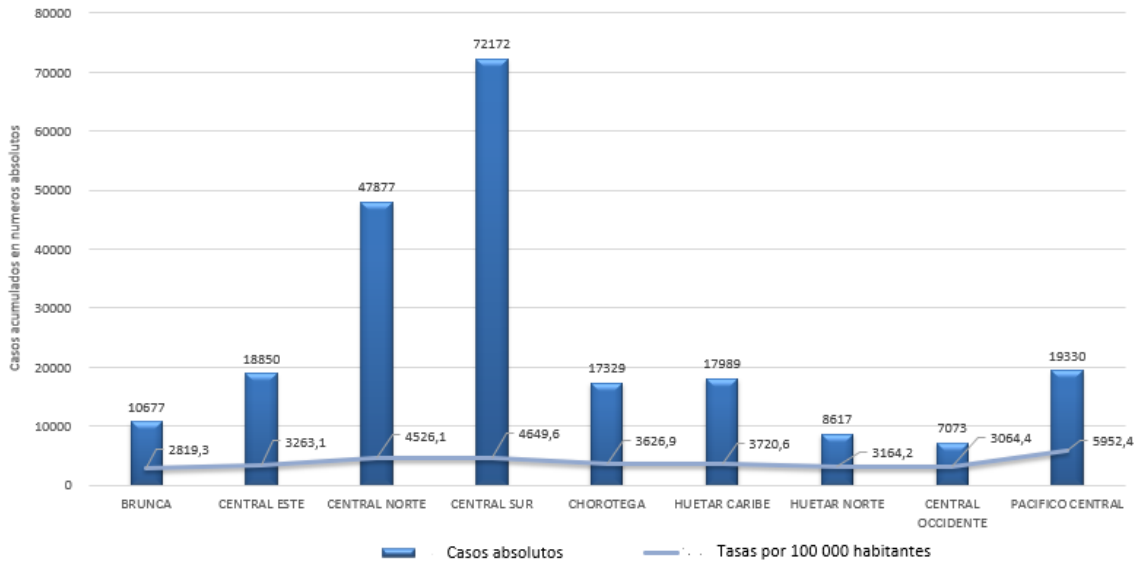
Gráfico 1
Costa Rica. Canal endémico para EDA por semana epidemiológica hasta la SE 25. Años 2017- 2025. (Se excluyen del 2020 al 2022 por pandemia COVID-19)



Fuente: Datos preliminares, Dirección Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud.

Los 12 cantones con mayores tasas de incidencia de EDA a la SE 27 son: Orotina, Vázquez de Coronado, Montes de Oro, Puntarenas, Santa Cruz, Garabito, , Flores, San Rafael, Matina, Alajuela, Goicochea, San José, Parrita, donde predominan las tasas más altas. Las Regiones Rectoras con más casos son: Pacifico Central, Central Norte, Central Sur. El grupo de edad más afectado es el de adultos de 20 a 39 años.

Gráfico 2
Costa Rica. Incidencia de casos de EDA, según región del Ministerio de Salud. SE 27, 2025.



Fuente: Datos preliminares. Dirección Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud.

Se recomienda retomar las campañas de educación a la población del Protocolo de Lavado de Manos, las adecuadas prácticas de higiene personal y de cocción y manipulación de alimentos.
El sistema de salud reporta una alta frecuencia de casos de diarreas, ya sean virales o bacterianas, superiores al comportamiento usual, el Protocolo de Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Alimentos dirige el proceso de la investigación adecuada de los casos, así como los flujogramas de trabajo ante diferentes posibles causas, es importante retomar las actividades de vigilancia e investigación ante las alertas.

Infecciones de transmisión sexual

Pamela Domínguez Saavedra
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Stephany Alvarado Garita
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

Rafael Alberto Chaves Méndez
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

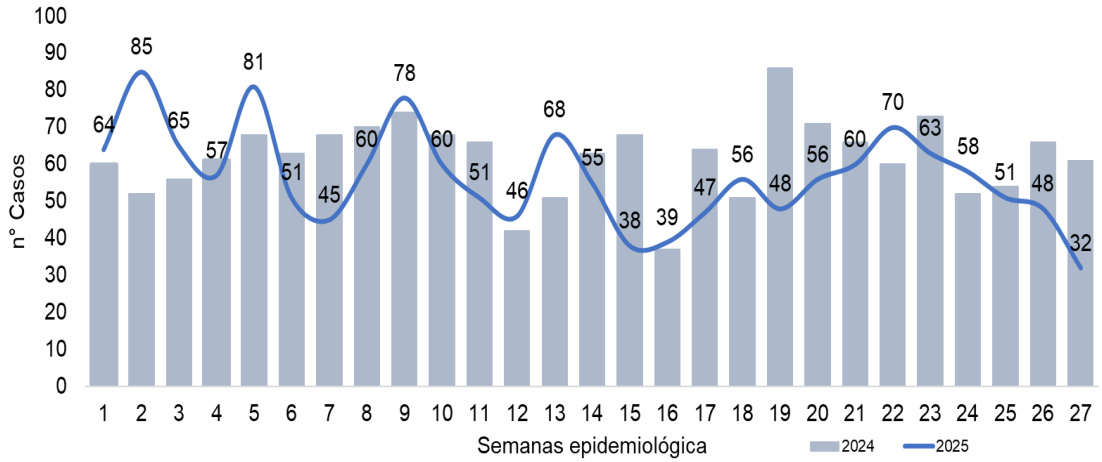
Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), son de reporte obligatorio según el Reglamento de Vigilancia de la Salud 40556-S. Por consiguiente, la vigilancia es relevante para la salud pública del país. Para las primeras 27 semanas del año 2025, se han reportado las siguientes ITS: sífilis en todas sus formas, gonorrea, herpes virus y virus del papiloma humano.

Sífilis en todas sus formas

Es una enfermedad de transmisión sexual causada por la bacteria *Treponema pallidum*, la cual es totalmente prevenible y tratable. Esta infección se trasmite por relaciones sexuales sin el uso de condón y de la madre al bebé durante el embarazo. Por ende, esta infección afecta a la morbilidad y mortalidad del país.

Para las primeras 27 semanas del 2025, se han notificado 1532 casos con una tasa 28,6 por 100 000 habitantes, en el mismo periodo del año 2024 se reportaron 1671 casos, lo que representa para el año 2025 un descenso del 8,31% con 139 casos menos. En el gráfico 1, se presenta los datos según reporte semanal.

Gráfico 1.
Costa Rica: Casos confirmados por sífilis en todas sus formas, según fecha de inicio de síntomas en el reporte semanal, en los años 2024 y 2025.



Nota: Datos preliminares, sujetos a ser actualizados.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento epidemiológico de esta enfermedad en las primeras 27 semanas del año, se reportaron en los hombres un 57,4% de los casos (880/1532), con una tasa de 32,7 por 100 000 habitantes, las mujeres presentan el 42,5% de los casos (652/1532), con una tasa de 24,5 por 100 000 habitantes.

Los casos notificados por grupos de edad con mayor reporto son: 20 a 64 años con 80,87% (1239/1532), seguidos por el de mayores de 65 años con 9,5% con (146/1532), luego por el grupo de 15 a 19 años con 4,7% con (72/1532), y los menores de 1 año con el 4,7% de los casos (72/1532), los menores de 10 a 14 años un caso, grupo de 1 a 4 años dos casos y el grupo de 5 a 9 años sin caso, ver cuadro 1.

Cuadro 1.
Costa Rica: Casos de sífilis en todas sus formas, por grupos de edad, número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 27 del 2025.

Grupos de edad	Casos	Tasa
de Menos de 1 año	72	106,6
de 1 a 4 años	2	0,7
de 5 a 9 años	0	0,0
de 10 a 14 años	1	0,3
de 15 a 19 años	72	19,0
de 20 a 24 años	190	48,9
de 25 a 29 años	239	56,2
de 30 a 34 años	230	51,8
de 35 a 39 años	171	37,8
de 40 a 44 años	131	32,1
de 45 a 49 años	102	29,4
de 50 a 54 años	62	21,1
de 55 a 59 años	54	19,4
de 60 a 64 años	60	22,9
de 65 a 69 años	45	21,1
de 70 a 74 años	39	25,0
75 años y más	62	29,4
Total	1532	28,60

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el siguiente cuadro, se presenta el comportamiento de esta enfermedad, según provincias.

Cuadro 2. Costa Rica: Casos notificados de sífilis en todas sus formas según provincias de procedencia. Números absolutos. (Tasa p/100.000 habitantes), en semana 27 del 2025.

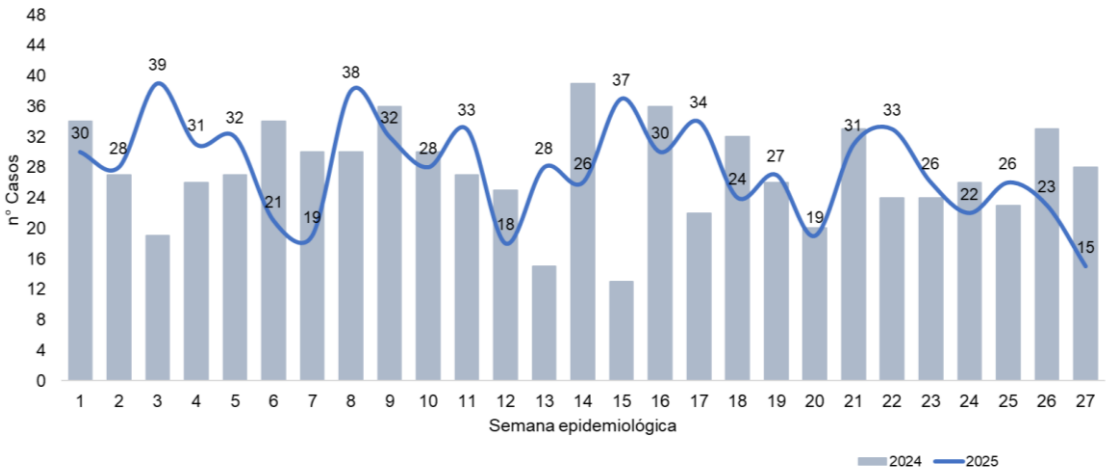
Provincias	Nº	Tasa
San José	526	30,6
Alajuela	248	22,7
Cartago	200	36,0
Heredia	115	20,6
Guanacaste	76	18,1
Puntarenas	115	21,8
Limón	252	52,1
Total	1532	28,60

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Gonorrea

Es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria *Neisseria gonorrhoeae*, la cual es prevenible y tratable. Esta enfermedad se trasmite por relaciones sexuales sin protección y de la madre al bebé durante el parto. Por consiguiente, esta infección afecta a la salud pública del país, en las primeras 27 semanas del 2025, se han notificado 750 casos con una tasa de 14,0 por 100 000 habitantes. En el mismo periodo del año 2024 se reportaron 739 casos, lo que representa para el año 2025 un ascenso del 1,5 % con 11 casos más. En el gráfico 2, se presenta los datos según reporte semanal.

Gráfico 2
Costa Rica: Casos notificados por gonorrea, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en los años años 2024 y 2025.



Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento de esta enfermedad en las primeras 27 semanas del 2025, se reporta en los hombres un 84,0% de los casos (630/750), con una tasa de 23,4 por 100 000 habitantes. En las mujeres se ha reportado el 10,0% de los casos (120/750), con una tasa de 4,5 por 100 000 habitantes.

Los casos notificados por grupos de edad con mayor reporte son: 20 a 64 años con 82,3% (617/750), seguidos por el grupo de 15 a 19 año con 14,4% (108/750), y los mayores de 65 años con 2,1% (16/750), los menores de 1 año dos casos y los de 1 a 14 años con siete casos, ver cuadro 3.

Cuadro 3
Costa Rica: Casos de gonorrea por grupos de edad, número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 27 del 2025

Grupos de edad	Casos	Tasa
Menos 1 año	2	3,0
1 a 4	2	0,7
5 a 9	1	0,3
10 a 14	4	1,1
15 a 19	108	28,5
20 a 24	186	47,9
25 a 29	145	34,1
30 a 34	108	24,3
35 a 39	75	16,6
40 a 44	38	9,3
45 a 49	17	4,9
50 a 54	22	7,5
55 a 59	18	6,5
60 a 64	8	3,1
65 a 69	10	4,7
70 a 74	3	1,9
Más 75 años	3	1,4
Total	750	14,00

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el cuadro 4, se presentan el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las siete provincias del país.

Cuadro 4
Costa Rica: Casos notificados por gonorrea, según provincia. Número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 27 del 2025

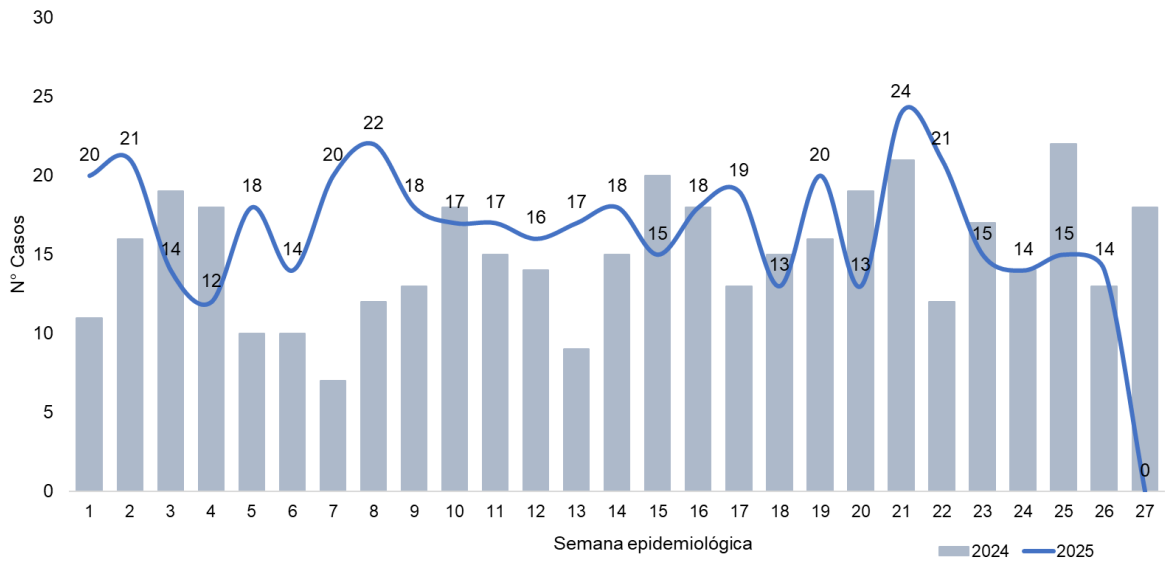
Provincias	Casos	Tasa
San José	272	15,8
Alajuela	110	10,1
Cartago	66	11,9
Heredia	68	12,2
Guanacaste	39	9,3
Puntarenas	84	15,9
Limón	111	23,0
Total	750	14,00

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Virus Herpes

El virus del herpes es otra de las Infección de transmisión sexual, que se ha reportado en las primeras 27 semanas del año en curso, con 445 casos con una tasa de 8,3 por 100 000 habitantes. En el mismo periodo del año 2024 se reportaron 405 casos, lo que representa para el año 2025 un incremento del 10,0%, con 40 casos más que el periodo anterior. En el gráfico 3, se presenta los datos según reporte semanal.

Gráfico 3.
Costa Rica: Casos notificados por el virus del herpes, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en los años 2024 y 2025.



Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento del virus del herpes en las primeras 27 semanas del año se ha notificado en mujeres un 67,4% de los casos (300/445), con una tasa de 11,3 por 100 000 habitantes, en hombres se reportó el 32,6% de los casos con (145/445), con una tasa de 5,4 por 100 000 habitantes.

Los casos notificados por grupos de edad y los que reportan más son: 20 a 64 años con 81,8% (364/445), seguidos por 15 a 19 años con 13,0% (58/445), mayores de 65 años con 4,0% con (18/445), los menores de 1 año reportan un caso y el de 10 a 14 años con cuatro casos, los otros grupos no reportan casos, ver cuadro 5.

Cuadro 5.
Costa Rica: Casos de virus del herpes, por grupos de edad, número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 27 del 2025.

Grupos de edad	Caso	Tasa
Menos 1 año	1	1,5
1 a 4	0	0,0
5 a 9	0	0,0
10 a 14	4	1,1
15 a 19	58	15,3
20 a 24	83	21,4
25 a 29	65	15,3
30 a 34	61	13,7
35 a 39	53	11,7
40 a 44	33	8,1
45 a 49	27	7,8
50 a 54	10	3,4
55 a 59	16	5,7
60 a 64	16	6,1
65 a 69	11	5,1
70 a 74	5	3,2
Más 75 años	2	0,9
Total	445	8,30

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el cuadro 6, se presenta el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las siete provincias del país.

Cuadro 6
Costa Rica: Casos notificados por virus del herpes, según provincias. Número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 27 del 2025

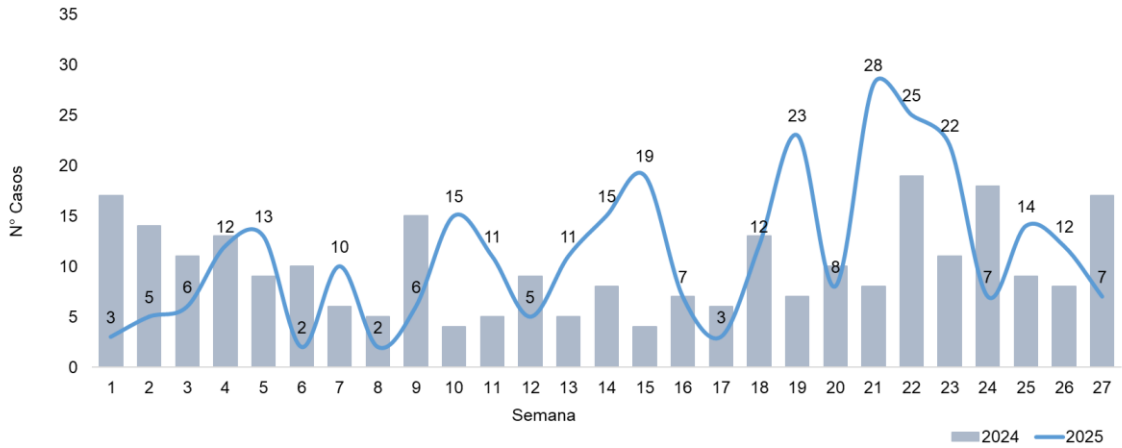
Provincias	Casos	Tasa
San José	216	12,6
Alajuela	47	4,3
Cartago	30	5,4
Heredia	31	5,5
Guanacaste	10	2,4
Puntarenas	55	10,4
Limón	56	11,6
Total	445	8,30

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Virus del Papiloma Humano (VPH)

Es una de Infección que se trasmite por contacto de la piel o por relaciones sexuales sin protección, se puede prevenir con el uso de condones y no tener relaciones sexuales cuando la pareja tiene síntomas. En las primeras 27 semanas del 2025, se notificaron 303 casos con una tasa de 5,7 por 100 000 habitantes. En el mismo periodo del año 2024 se reportaron 268 casos, lo que representa para el año 2025 un incremento del 13,0%, con 35 casos más que el periodo anterior ver gráfico 4.

Gráfico 4
Costa Rica: Casos notificados por virus del papiloma humano, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en los años 2024 y 2025



Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento del VPH en las primeras 27 semanas del año, según sexo se notificaron en las mujeres un 89,1% (270/303), con una tasa de 10,0 por 100 000 habitantes, en los hombres se reportó el10,9% (33/303), con una tasa de 1,2 por 100 000 habitantes.

Los casos notificados por grupos de edad con mayor reporte son: 20 a 64 años con 96,7% (293/303), seguidos por 15 a 19 años con 2,6% (8/303), los mayores 65 años dos casos y los otros grupos no reportan casos, ver cuadro 7.

Cuadro 7.
Costa Rica: Casos notificados por virus del papiloma humanos, por grupos de edad. Número absoluto. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 27 del 2025.

Grupos de edad	Casos	Tasa
de Menos de 1 año	0	0,0
de 1 a 4 años	0	0,0
de 5 a 9 años	0	0,0
de 10 a 14 años	0	0,0
de 15 a 19 años	8	2,1
de 20 a 24 años	22	5,7
de 25 a 29 años	20	4,7
de 30 a 34 años	52	11,7
de 35 a 39 años	63	13,9
de 40 a 44 años	38	9,3
de 45 a 49 años	33	9,5
de 50 a 54 años	20	6,8
de 55 a 59 años	28	10,0
de 60 a 64 años	17	6,5
de 65 a 69 años	2	0,9
de 70 a 74 años	0	0,0
75 años y más	0	0,0
Total	303	5,70

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Cuadro 8.
Costa Rica: Casos notificados por virus del papiloma humano, según provincia. Número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 27 del 2025

Provincias	Nº	Tasa
San José	87	5,1
Alajuela	27	2,5
Cartago	14	2,5
Heredia	7	1,3
Guanacaste	39	9,3
Puntarenas	125	23,7
Limón	4	0,8
Total	303	5,70

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Miasis por gusano barrenador en humanos

María José Lafuente González
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

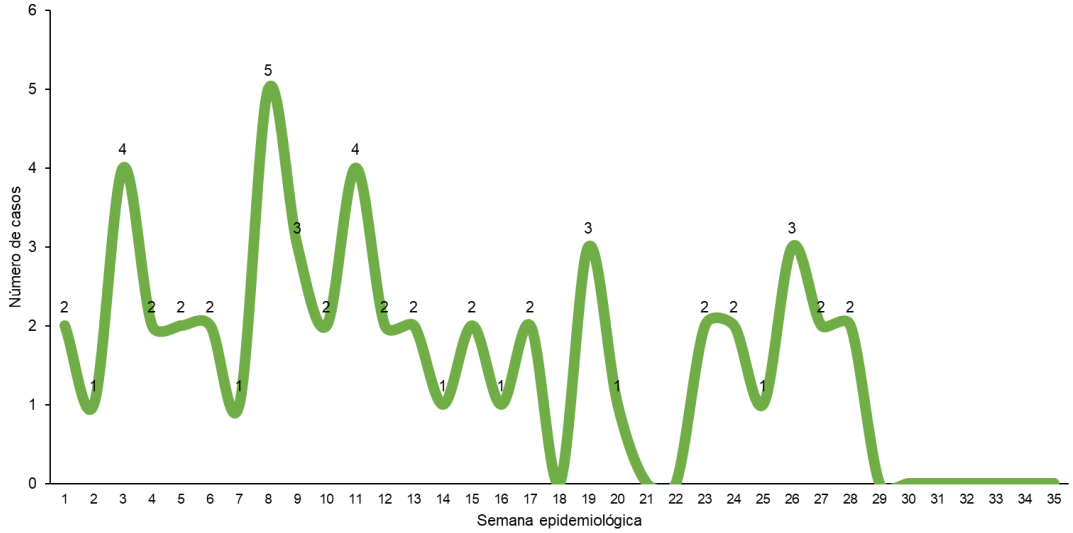
Rafael Alberto Chaves Méndez
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

A continuación, se presentan los datos de miasis por gusano barrenador en humanos para la semana epidemiológica (SE) 28 del año 2025, según establece el Reglamento de Vigilancia de la Salud Decreto N°40556-S y el Lineamiento Nacional para la Vigilancia de Miasis por Gusano Barrenador en Humanos es un evento de notificación obligatoria al Ministerio de Salud.

En relación con la notificación de esta miasis, por medio de la boleta VE-01, para el año 2025 a la SE 28, se tienen los siguientes datos:

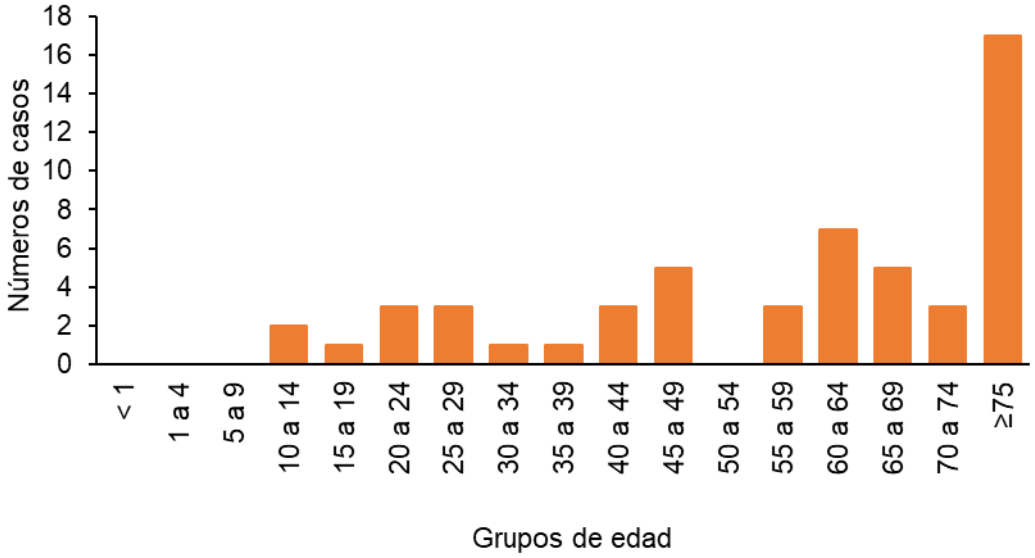
- Casos acumulados de miasis por gusano barrenado en humanos suman un total de 54 casos
- Casos por grupos de edad quinquenal tienen un predominio en las personas de 20 a 64 años (26/54) y las adultas de 65 y más años con más casos reportados (25/54).

Gráfico 1
Costa Rica: Casos notificados de miasis de gusano barrenador según SE de la 01 a la 28, 2025



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

Gráfico 2
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador según grupos de edad quinquenal, de la SE 01 a la 28, 2025



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

El comportamiento de la miasis por gusano barrenador en humanos, en el año 2025, presenta un predominio en los hombres con 35 casos notificados con una tasa de 1,3 por 100.000 habitantes y en las mujeres con 19 casos notificados con una tasa de 0,7 por 100.000 habitantes.

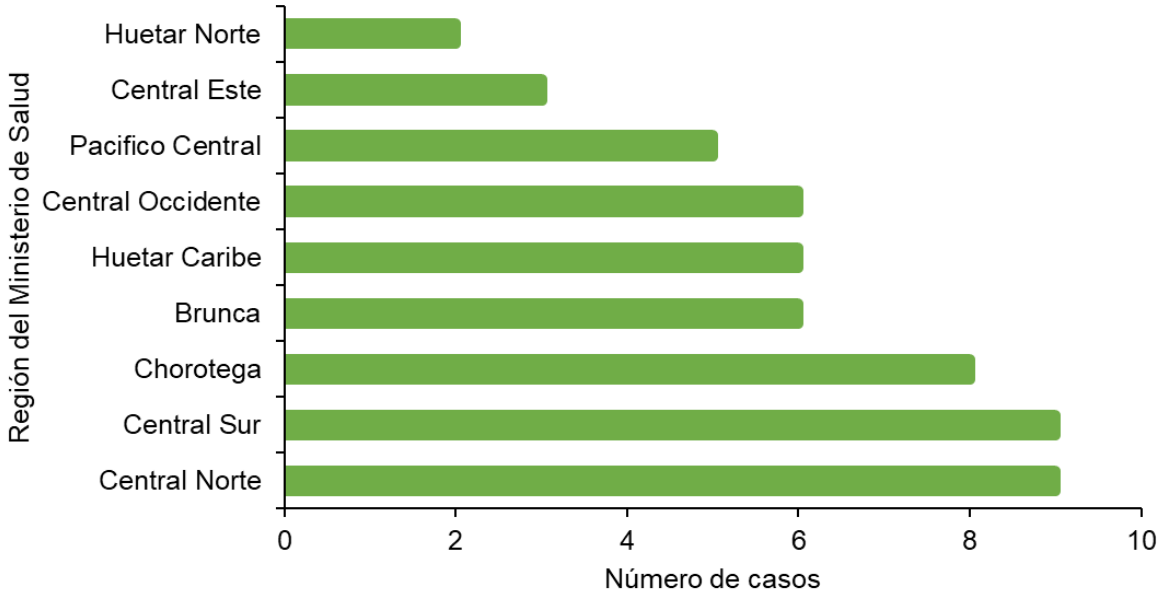
Cuadro 1
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por número de casos y tasas (tasa p/100.000 habitantes) según provincia de procedencia, de la SE 01 a 28, 2025

Provincias	Casos	Tasas
Total	**54**	**1,0**
San José	10	0,6
Alajuela	13	1,2
Cartago	3	0,5
Heredia	5	0,9
Guanacaste	8	1,9
Puntarenas	9	1,7
Limón	6	1,2

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

En el cuadro 1, se presenta el comportamiento de esta enfermedad por provincia de procedencia, por casos y tasas por 100.000 habitantes notificados a la SE 28, presentando mayor número de casos la provincia de Alajuela (13/54) seguido por la provincia de San José (10/54).

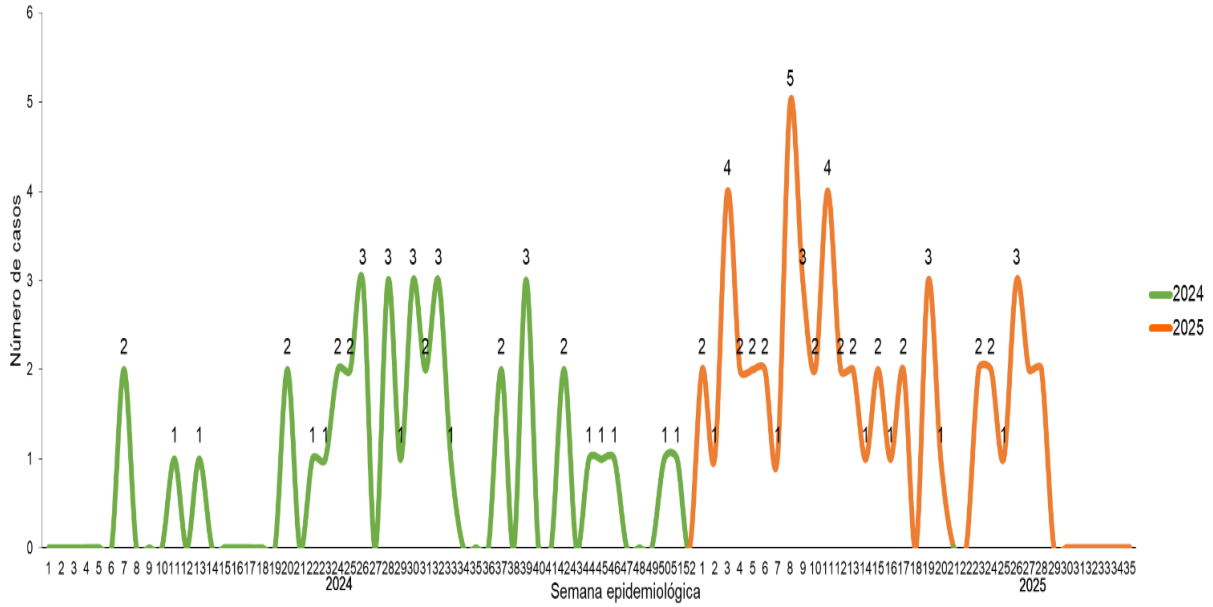
Gráfico 3
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por número de casos según región del Ministerio de Salud de procedencia, de la SE 01 a 28, 2025



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

En el gráfico 3, se presenta el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las nueve regiones del Ministerio de Salud, siendo la región Central Norte (9/54) y Centra Sur (9/54) la que presenta el mayor número de casos.

Gráfico 4
Costa Rica: Casos notificados de miasis de gusano barrenador, según SE, año 2024 al corte de la SE 28 del 2025.



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2024 y 2025

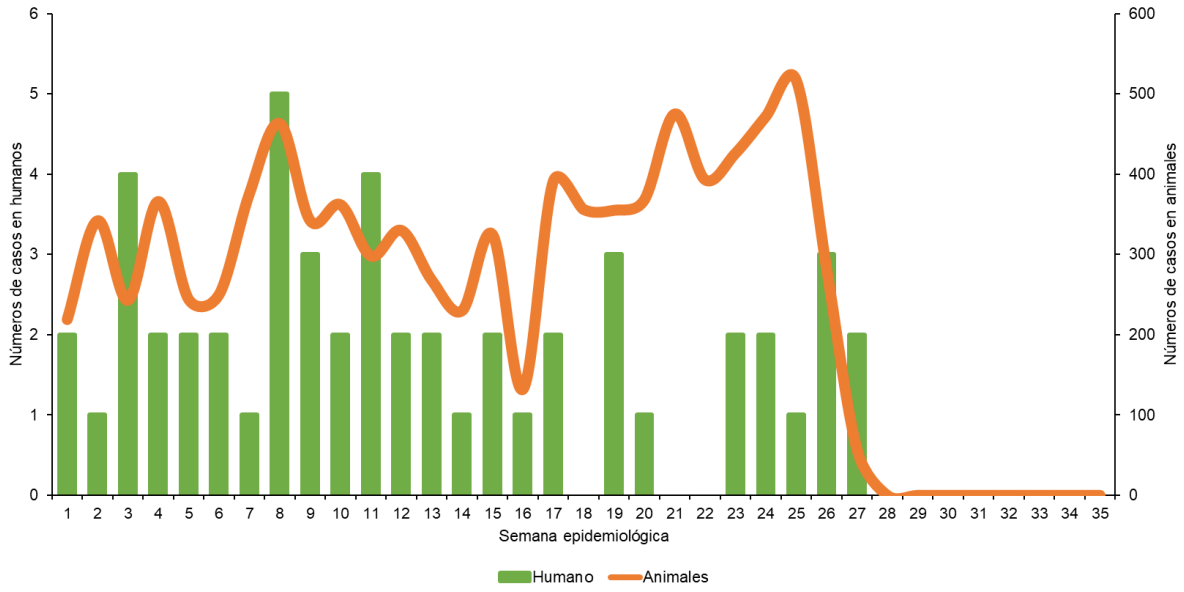
Cuadro 2
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador a la SE 28 del 2024 y 2025

SE	Número de casos	
	2024	2025
1	0	2
2	0	1
3	0	4
4	0	2
5	0	2
6	0	2
7	2	1
8	0	5
9	0	3
10	0	2
11	1	4
12	0	2
13	1	2
14	0	1
15	0	2
16	0	1
17	0	2
18	0	0
19	0	3
20	2	1
21	0	0
22	1	0
23	1	2
24	2	2
25	2	1
26	3	3
27	0	2
28	3	2
Total	**18**	**54**

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2024 y 2025

En el gráfico 4 se puede observar el comportamiento de la miasis por gusano barrenador en humanos por SE 01 a 52 del 2024 y SE 01 a 28 del 2025 y en el cuadro 2 el comportamiento de los casos de la SE 01 a 28 del 2024 y SE 01 a 28 del 2025, observando un aumento significativo de los casos durante la SE 08 del 2025, con un total de 54 casos confirmados por esta enfermedad, siendo que para la SE 28 del 2024 se confirmaron 18 casos de miasis por gusano barrenador en el país.

Gráfico 5
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador en humanos y animales según SE de la 01 a la 27, 2025



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Boletín Epidemiológico Extraordinario Gusano Barrenador actualizado al 05 de julio del 2025, SENASA / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

En el gráfico 5, se muestran los casos de miasis por gusano barrenador en humanos y animales por SE de la 01 a la 27 del 2025, con 52 casos confirmados en humanos y 8882 casos confirmados en animales.

Dado que la mosca continúa circulando en el territorio nacional y existe la declaratoria de Emergencia Nacional Sanitaria Epidémica para el control y erradicación de la enfermedad de Gusano Barrenador, Decreto Ejecutivo N° 44382–MAG (*Cochliomyia hominivorax*), es de suma importancia que ante la identificación de un caso sospechoso en humanos se realice el abordaje bajo el enfoque de **Una**

Sola Salud, mediante coordinación interinstitucional Ministerio de Salud-Servicio Nacional de Salud Animal-Ministerio de Ambiente y Energía según corresponda, para identificar casos sospechosos en humanos y/o animales que puedan ser atendidos de manera oportuna.
A continuación, se brinda algunas generalidades de prevención y control de esta enfermedad:

- Mantener higiene personal, lavarse las manos regularmente con agua y jabón
- Control, tratamiento e higiene en lesiones en piel de acuerdo con la recomendación del médico tratante
- Asistir al establecimiento de salud público o privado cuando presente síntomas asociados a la enfermedad, tales como: dolor, malestar y picazón en el sitio de la lesión, enrojecimiento de la piel, herida con secreción, sensación que se mueve y con frecuencia, se pueden observar huevecillos y/o larvas visibles en la lesión herida
- Mantener vigilancia y control en el cuidado de los animales, realizando revisiones frecuentes, así como la curación de todas las heridas e informar a las autoridades de salud animal (SENASA) sobre la aparición de animales con gusaneras para que reciban atención oportuna

Reporte del primer semestre de Recolección de llantas en desuso

Pamela Monestel Zúñiga
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Olga Segura Cárdenas
Dirección Protección Radiológica y Salud Ambiental

Elsie Álvarez Monge
Fundellantas

El siguiente informe responde a las campañas de recolección de llantas en desuso realizadas por las Direcciones de Área Rectora de la Salud (DARS) a nivel nacional durante el primer semestre del 2025.

En este año seguimos trabajando de la mano con Fundellantas como aliado estratégico para la recolección de llantas en desuso. No obstante, este año se suman al proyecto el Instituto de Fomento y Ayuda Municipal (IFAM) y la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) como aliados estratégicos que brindan apoyo local y nacional en la divulgación y promoción de dichas campañas.



Fuente: DARS de Talamanca (2025) Campaña de recolección de llantas

Desde enero del 2025 todas las DARS del Ministerio de Salud iniciaron las coordinaciones con diversos actores institucionales para realizar las campañas de recolección de llantas, como una acción preventiva que contribuye a la eliminación los criaderos del Aedes aegypti.
Las Direcciones regionales que realizaron durante este primer semestre campañas de recolección de llantas en desuso fueron:

- Pacífico Central
- Chorotega
- Brunca
- Huetar Caribe
- Central Este
- Central Norte
- Central Sur
- Huetar Norte
- Occidente

Las Direcciones de Área Rectora de la Salud (DARS) que ejecutaron campañas de recolección de llantas en desuso para el primer semestre del 2025 fueron:

- Guatuso
- Santa Rosa
- Garabito
- Liberia
- Limón
- Orotina - San Mateo
- Cartago
- Guácimo
- Coto Brus
- Matina
- Corredores
- Pococí-Guápiles
- Talamanca
- Atenas
- Coto Brus
- Tibás
- Ciudad Quesada
- Limón
- Aguas Zarcas
- Nandayure
- Palmares
- Florencia



Fuente: DARS de Talamanca. Río Telire (2025) Campaña de recolección de llantas en Territorio Indígena Bribri.

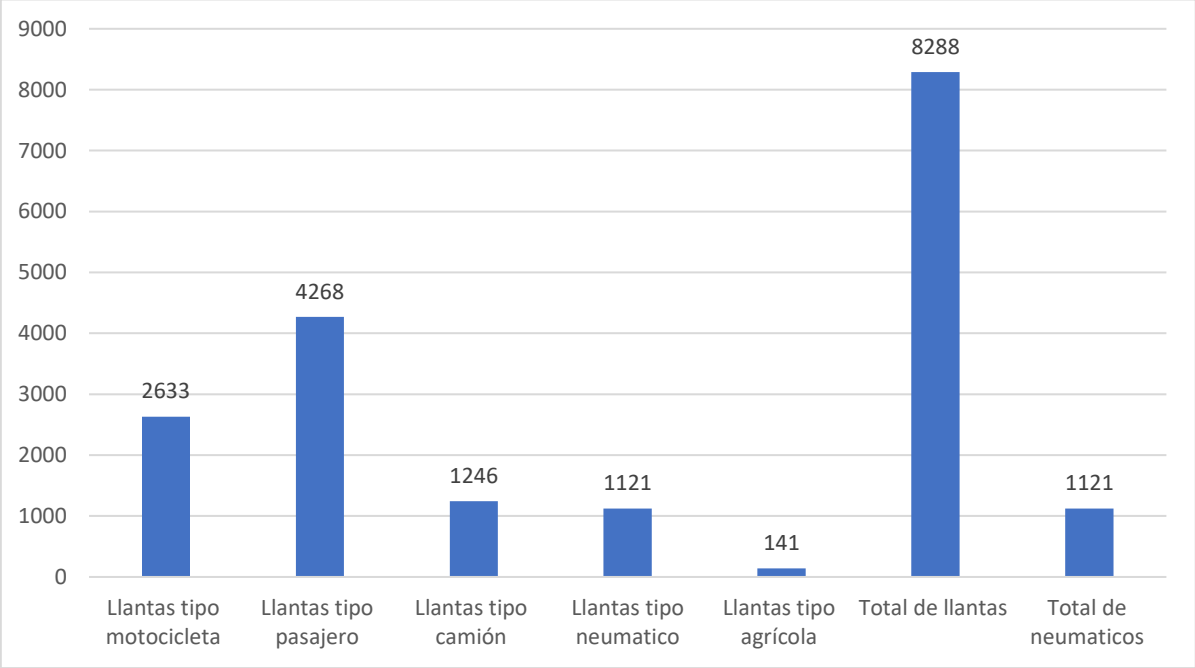
Los procesos de gestión involucrados en las campañas a nivel local han sido: Vigilancia de la salud, Manejo integrado de vectores, Regulación, Promoción de la salud, Planificación y Atención del cliente. Además, las campañas se coordinaron con diversos actores institucionales.

El total invertido de horas funcionario y funcionaria tanto del Ministerio de Salud como de otras instituciones fue de 1243 horas. Esto representa un gran esfuerzo e inversión para llevar a cabo las campañas de recolección de llantas.

Durante este primer semestre se recolectaron un total de 8288 llantas en desuso.

En cuanto las llantas tipo motocicleta se recuperaron 2633, llantas tipo pasajero 4268, llantas tipo camión 1246 y tipo agrícola 141. En cuanto a los neumáticos se recuperaron un total de 1121.

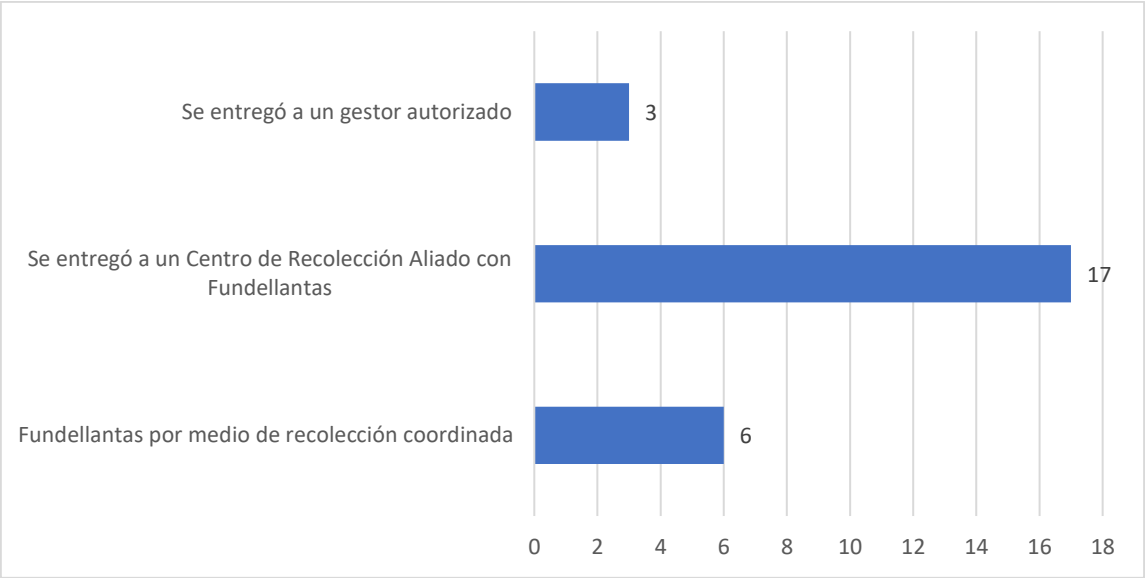
Gráfico 1.
Costa Rica: Número total de llantas en desuso recolectadas. Primer semestre 2025



Fuente: Ministerio de Salud, Unidad de Epidemiología

En general 17 DARS entregaron las llantas a un centro de recolección aliado de Fundellantas, 6 DARS coordinaron la recolección directo con Fundellantas y 3 DARS las depositaron en un gestor autorizado por el Ministerio de Salud. De esta forma el Ministerio de Salud se asegura el realizar una adecuada disposición de las llantas en desuso.

Gráfico 2
Costa Rica: Lugar de entrega de las llantas recuperadas



Fuente: Ministerio de Salud, Unidad de Epidemiología

Con las campañas de recolección de llantas en este primer semestre se evitaron **254.85 toneladas de emisiones CO2** al sustituir combustible fósil derivado del petróleo por llantas de desecho en la industria cementera. Además de eliminar potenciales criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades aportamos a la descarbonización evitando emisiones responsables del cambio climático. Reconocer el trabajo de los coordinadores de las campañas en el primer semestre a nivel regional y local:

- Karla Céspedes Murrillo
- Susana Chaves Herra
- Wilson González Arce
- Leda Pena Garita
- Yendry Mendoza
- Christoplher Quesada Guido
- José Herrera Ramírez
- Carlos Torres Alvarado
- Melissa Martínez Molina
- Sujey Ramírez Mena
- Luis Mauricio Mora Villalobos

- Karla Vega Molina
- Lucrecia Altamirano Cascante
- Gioconda Rivera Barquero
- Ronny González Acosta
- Francinie Esquivel Arrieta
- Elena Fernández Monge
- Meylin Balladares Centeno
- Luis Mauricio Mora Villalobos
- Rosario Quesada Varela
- María del Milagro Picado Cartín
- Juan Ríos Guevara
- Belladira Ramírez Jiménez
- Jesús Martínez Pizarro
- Adrián Rojas González
- Rebeca Campos Artavia
- Carolina Pérez González